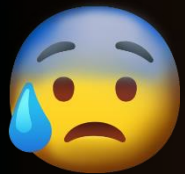


migrétil®



# PORQUE LA MIGRAÑA ES ALGO MÁS QUE UN DOLOR DE CABEZA

Panamá, 06/04/2022

Bial

migrétil®

# MIGRAÑA



La migraña es un tipo de cefalea idiopática, benigna, recurrente, que se manifiesta con ataques que suelen durar entre **4 Y 72 HORAS.**



La migraña es un **TRASTORNO DE CEFALEA NEUROVASCULAR COMÚN,** multifactorial, incapacitante, recurrente y hereditario.

**DOLOR INTENSO,  
PULSÁTIL,  
PALPITANTE**

**DURACIÓN  
DE 4 A 72H**

Charles A. Migraine. N Engl J Med. 2017 Ago 10;377(6):553-561

# DIAGNÓSTICO<sup>1</sup>

01

Sin aura

02

Con aura

UN PACIENTE PUEDE  
TENER AMBAS

No existen pruebas de  
diagnóstico para ninguna  
de las cefaleas primarias

## DIAGNÓSTICO DE LA MIGRAÑA<sup>3-6</sup>

Um mínimo de 5  
crisis de cefalea con:



**DOLOR DE  
CABEZA CON  
UNA DURACIÓN  
DE 4 A 72H**

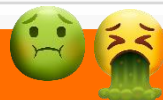
- ▶ Unilateral (solo un lado de la cabeza)
- ▶ Pulsátil o palpitante
- ▶ De moderado a severo



Agravado por el movimiento



**AL MENOS  
DOS DE  
ESTOS  
SÍNTOMAS**



**NÁUSEAS  
O VÓMITOS**

**SENSIBILIDAD/  
INTOLERANCIA A:**



La luz (fotofobia)



El ruido (fonofobia)



**AL MENOS  
UNO DE  
ESTOS  
SÍNTOMAS**

- ▶ Los olores intensos

**CON O  
SIN AURA**

1- Comité de Clasificación de Cefaleas de la International Headache Society (IHS). The International Classification of Headache Disorders, 3.<sup>a</sup> edición (versión beta). Cephalalgia. 2013 Jul;33(9):629-808.

Adaptado de Headache Classification Committee of the International Headache Society (IHS). The International Classification of Headache Disorders, 3rd edition. Cephalalgia. 2018 Jan;38(1):1-211.

# FACTORES DESENVADENANTES

La migraña puede iniciarse o amplificarse como consecuencia de diversos estímulos, que varían de persona a persona o que incluso son siempre los mismos para diferentes ataques en la misma persona.



## ALTERACIONES EN EL PATRÓN DE SUEÑO

Falta o exceso de sueño



## ALIMENTACIÓN

Ayuno prolongado o saltarse comidas, deshidratación, consumo de alcohol y de algunos alimentos (p.ej.: queso, chocolate, cítricos...)



## FLUCTUACIONES HORMONALES

Menstruación o menopausia



## FÍSICOS

Actividad física intensa, fatiga/cansancio



## PSICOLÓGICOS

Estrés (y relajamiento posestrés), ansiedad, depresión



## ESTÍMULOS SENSORIALES

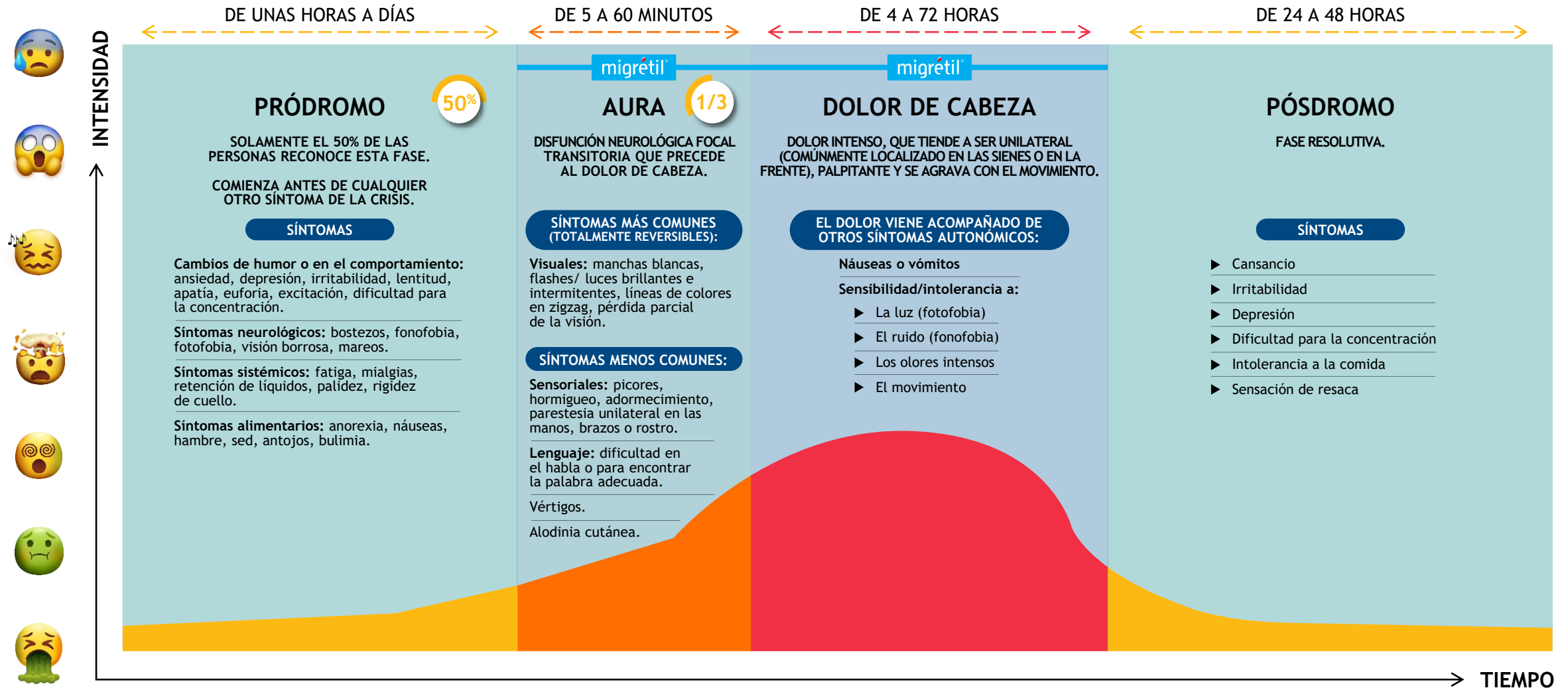
Luces brillantes o intermitentes, ruidos y olores intensos



## ALTERACIONES AMBIENTALES

Presión, temperatura, humo/contaminación

# ETAPAS DE LA MIGRAÑA



\* No todos los pacientes experimentan estas cuatro fases, pues estas pueden variar en función de la crisis. Además, las fases pueden solaparse.<sup>11</sup>  
Adaptado de MigraPortugal (disponible en: <https://migraportugal.pt/sobre-cefaleias/enxaqueca/>)

# TRATAMIENTO

No farmacológico.

Farmacológico.

# TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO

Los medicamentos para usar en crisis se pueden dividir en:

## Terapia sintomática

- ✓ AINEs (naproxeno, ibuprofeno): reducen la gravedad y la duración del ataque de migraña
- ✓ Analgésicos: Paracetamol (acetaminofén)
- ✓ Antagonistas de la dopamina (la absorción del fármaco se ve afectada durante la migraña debido a la reducción de la motilidad gástrica)

## Terapia específica

- ✓ Agonistas 5-HT<sub>1</sub> (ergotamina y triptanes)  
(Los pacientes tratados con ergotamina tienen una menor recurrencia de la cefalea que los pacientes tratados con triptanos, si bien parecen tener una incidencia mucho mayor de náuseas)
- ✓ Asociaciones de varios principios activos (e.g. Migrétil)

## EFICACIA ESTABLECIDA

## PROBABLEMENTE EFICAZ

Específico para la migraña

**Triptanes**

Ergotamina

**Derivados de la ergotamina**

Otras formas de dihidroergotamina

Gepantes

Lasmiditan

No específicos

**AINEs: Aspirina, Celecoxib solución oral, diclofenaco, ibuprofeno, naproxeno**

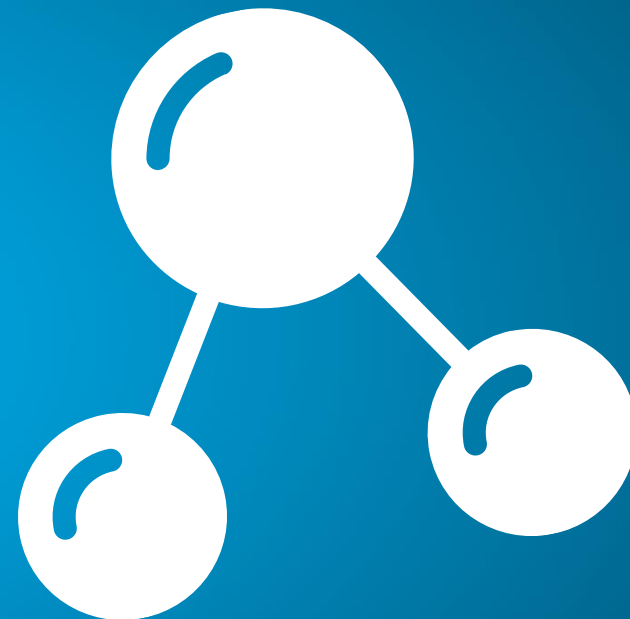
**AINEs:** Flurbiprofeno, Ketoprofeno, IV y Ketorolac IM

**Analgésico combinado: Acetaminofén + Aspirina + Cafeína**

Magnesio IV

Compuestos con isometepteno

**Antieméticos:** clorpromazina, droperidol, metoclopramida, proclorperazina, prometazina



Adaptado de Ailani J, Burch RC, Robbins MS; Board of Directors of the American Headache Society. The American Headache Society Consensus Statement: Update on integrating new migraine treatments into clinical practice. Headache. 2021 Jul;61(7):1021-1039

# MIGRÉTIL



Bial

**PARACETAMOL**  
**400 mg**

**CAFEÍNA**  
**100 mg**

**TARTRATO DE**  
**ERGOTAMINA**  
**1 mg**

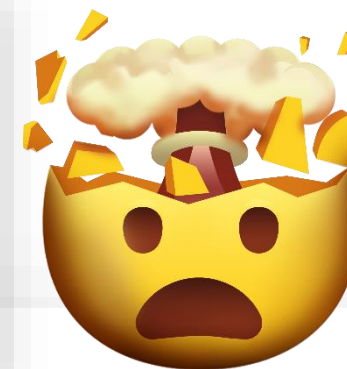
**ALCALOIDES DE**  
**BELLADONA**  
**0,1 mg**

# MIGRÉTIL



Bial

## PARACETAMOL 400 mg



- Efecto analgésico y antipirético (por un mecanismo que no se conoce completamente).
- Efecto analgésico
  - Puede actuar inhibiendo la síntesis de prostaglandinas en el SNC.
  - Bloquea la génesis del impulso del dolor, periféricamente (por inhibición de las prostaglandinas y de otras sustancias).
- Se absorbe rápida y casi completamente en el tracto gastrointestinal (C<sub>máx</sub> obtenida en 10-60 minutos).
- Se excreta por vía urinaria.

# MIGRÉTIL



Bial

CAFEÍNA  
100 mg



## Mecanismos de acción:

- Potencia la acción de la ergotamina al aumentar su absorción intestinal.
- Puede contribuir a la vasoconstricción cerebral y, como consecuencia, a la reducción del flujo sanguíneo y de la tensión local de oxígeno.
- La cafeína no ejerce ningún efecto analgésico intrínseco; sin embargo, se ha descrito que los preparados que contienen cafeína tienen un efecto analgésico más rápido y potente.
- Se absorbe fácilmente en el tracto gastrointestinal (C<sub>máx</sub> obtenida en 50-75 minutos).

# MIGRÉTIL



Bial

## TARTRATO DE ERGOTAMINA 1 mg



### Mecanismos de acción:

- No se comprende completamente, pero se cree que afecta a la vasoconstricción de las arterias carótidas externas con una disminución concomitante de la amplitud del pulso.
- Efecto sobre las catecolaminas y la serotonina.
- Presenta una absorción gastrointestinal variable. Por lo general, la absorción es mayor en la primera hora después de la administración oral y en conjunción con cafeína.
- Tiempo hasta la C<sub>máx</sub>: 1h (con cafeína).
- Excreción fecal (biliar).

# MIGRÉTIL



## ALCALOIDES DE BELLADONA 0,1 mg



- Los alcaloides de belladona ejercen un efecto antiemético beneficioso y contribuyen al alivio sintomático del ataque.
  - La estasis gástrica, las náuseas y los vómitos son síntomas y signos presentes en la mayoría de los casos de migraña.
- Se absorbe bien en el tracto gastrointestinal
- Excreción urinaria y fecal

# MIGRÉTIL



Bial

## INDICACIONES TERAPÊUTICAS

Tratamiento de los ataques de  
migraña.

No está indicado como tratamiento preventivo.

# POSOLOGÍA

## ADULTOS



2 comprimidos, de una sola vez, durante el aura o al inicio de la cefalea.

Si fuera necesario, administrar 1 comprimido adicional.

Si fuera necesario, administrar 1 comprimido adicional.

## ADOLESCENTES



1 comprimido, durante el aura o al inicio de la cefalea.

Si fuera necesario, administrar 1 comprimido adicional.

No está indicado para niños menores de 12 años.



- Los comprimidos deben tomarse tan pronto como sea posible, después de la aparición de los primeros signos de un ataque de migraña.
- No se deben tomar más de 6 comprimidos por día o 10-12 comprimidos por semana.
- Los comprimidos deben tragarse enteros, con un poco de agua.

## CONTRAINDICACIONES

- Hipersensibilidad a cualquiera de sus componentes
- Embarazo y lactancia >> puede provocar abortos y malformaciones fetales, por lo que no debe utilizarse durante el embarazo
- Alcoholismo activo
- Insuficiencia hepática significativa
- Angioplastia o cirugía vascular reciente o prevista
- Enfermedad vascular periférica oclusiva
- Hipertensión no controlada
- Enfermedad coronaria

## REACCIONES ADVERSAS

A LAS DOSIS RECOMENDADAS, MIGRÉTIL SUELE SER BIEN TOLERADO.

Sin embargo, puede producir algunos efectos indeseables:

- Reacciones cutáneas de hipersensibilidad
- Signos de irritación gástrica, náuseas y diarrea
- Insomnio, irritabilidad, vértigo
- Mialgia, parestesia y debilidad en los miembros inferiores
- Efectos vasoconstrictores (extremidades frías, adormecidas y dolorosas, con o sin parestesia)

## PRECAUCIONES ESPECIALES

- El riesgo de complicaciones aumenta en caso de infección grave, insuficiencia renal importante o edad avanzada.
- En pacientes con trastornos de ansiedad, la cafeína puede aumentar sus síntomas. Debe evitarse el uso concomitante de bebidas que contengan cafeína.
- Debido a los alcaloides de la belladona (propiedades anticolinérgicas), los pacientes con hipertrofia prostática, retención urinaria, enfermedad gastrointestinal oclusiva o glaucoma pueden reaccionar desfavorablemente, aunque las dosis incluidas son bajas.

# MIGRÉTIL



Bial

**DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO:** MIGRÉTIL. **COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA:** Paracetamol 400 mg; cafeína 100 mg; tartrato de ergotamina 1 mg; alcaloides de belladona 0,1 mg; por comprimido. **INDICACIONES TERAPÉUTICAS:** Tratamiento de las crisis de jaqueca: No está indicado como tratamiento preventivo. **POSOLOGÍA Y FORMA DE ADMINISTRACIÓN:** Salvo otra prescripción indicada por el médico, MIGRÉTIL se tomará de la siguiente manera: *Adultos:* Dos comprimidos a la vez, durante el aura o el inicio de la jaqueca. Si resulta necesario, administrar 1 comprimido después de media hora, y otro comprimido tras otra media hora si los síntomas persisten. *Adolescentes:* Un comprimido durante el aura o el inicio de la jaqueca. Si resulta necesario, administrar 1 comprimido después de media hora. No está indicado para niños menores de 12 años. Los comprimidos se tomarán lo más precozmente posible, tras los primeros síntomas de crisis de jaqueca. No ingerir más de 6 comprimidos al día o más de 10 o 12 comprimidos por semana. Los comprimidos se tomarán enteros con un poco de agua.

**CONTRAINDICACIONES:** Hipersensibilidad a los principios activos o a algún de los excipientes. Embarazo y lactancia; alcoholismo activo; insuficiencia hepática significativa. Angioplastia o cirugía vascular recientes o previstas; enfermedad vascular periférica oclusiva; hipertensión no controlada; enfermedad coronaria. **ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES ESPECIALES DE EMPLEO:** El riesgo de complicaciones aumenta en caso de infecciones graves, insuficiencia renal significativa y en los pacientes geriátricos. En los enfermos ansiosos la cafeína puede aumentar los síntomas. Debe evitarse el uso concomitante de bebidas conteniendo cafeína. Los enfermos con hipertrofia prostática, retención urinaria, enfermedad gastrointestinal oclusiva o glaucoma pueden ser objeto de acciones nocivas resultantes de los alcaloides de belladona, aunque las dosis utilizadas en MIGRÉTIL sean bajas. **INTERACCIONES CON OTROS MEDICAMENTOS Y OTRAS FORMAS DE INTERACCIÓN:** Las xantinas pueden incrementar los efectos de los estimulantes beta-adrenérgicos. La utilización concomitante de estimulantes del sistema nervioso central puede provocar efectos adicionales indeseables como, nerviosismo, irritabilidad, insomnio, convulsiones y arritmias. La utilización concomitante de inhibidores de la monoaminooxidasa puede causar taquicardia, arritmias o hipertensión. La cafeína antagoniza los efectos de la adenosina y de los bloqueadores beta. La administración concomitante de vasoconstrictores sistémicos (cocaína, epinefrina, metaraminol, metoxamina, norepinefrina, fenilefrina, soluciones anestésicas locales con vasoconstrictores, aminas simpaticomiméticas), así como el tabaquismo, potencian los efectos vasopresores de los alcaloides del cornezuelo del centeno. Esta clase de fármacos antagoniza los efectos vasodilatadores de la nitroglicerina. Hay que tomar precauciones especiales con la utilización simultánea de propranolol y dosis elevadas de alcaloides del cornezuelo del centeno, considerando el riesgo de vasoconstricción periférica grave. El consumo excesivo de alcohol puede aumentar el riesgo de hepatotoxicidad inducida por el paracetamol. La cafeína potencia los efectos de las otras xantinas, pudiendo disminuir la eliminación de éstas. La eritromicina y la troleandomicina disminuyen el metabolismo de los alcaloides del cornezuelo del centeno, aumentando el riesgo de vasospasmo.

**EMBARAZO Y LACTANCIA:** No utilizar durante el embarazo y la lactancia. **EFFECTOS SOBRE LA CAPACIDAD PARA CONDUCIR Y UTILIZAR MÁQUINAS:** No interfiere cuando se utilizan las dosis recomendadas. **REACCIONES ADVERSAS:** A las dosis recomendadas MIGRÉTIL es habitualmente bien tolerado. Pueden ocurrir reacciones de hipersensibilidad cutánea, signos de irritación gástrica, diarrea, insomnio, nerviosismo, mialgias, parestesias y disminución de fuerza en los miembros inferiores. Los efectos de vasoconstricción suelen sentirse en cualquier vaso, existiendo una gran variabilidad individual. Estos efectos suelen manifestarse por extremidades frías, adormecidas y dolorosas, con o sin parestesias. **SOBREDOSIS:** Casos de sobredosis o intoxicación aguda pueden aparecer, ocasionalmente, en enfermos que toman dosis más altas que las recomendadas o en individuos con intentos suicidas. Los síntomas de sobredosis pueden incluir náuseas, vómitos, dolor abdominal, cefaleas, excitabilidad, agitación, escotomas, tinnitus, temblores, taquicardia, arritmias, aumento de la diuresis, mialgias, parestesias, disminución de la fuerza de los miembros inferiores y extremidades frías, adormecidas o dolorosas. En casos más graves puede observarse angor, ceguera monocular transitoria, papilitis bilateral, colitis isquémica, vasoconstricción de la arteria renal, gangrena en las extremidades, necrosis hepática, alteración de la función mental, delirium, disnea, hipo o hipertensión, pulso débil, espasmos musculares, convulsiones, shock y muerte. El tratamiento de las situaciones de sobredosis aguda consiste en medidas generales de soporte y tratamiento sintomático. La inducción del vómito y lavado gástrico son importantes si la ingesta del fármaco hubiera sido efectuada hace menos de 4 horas, así como la administración de carbón activado. La utilización de demulcentes puede reducir la irritación gástrica. Habrá que prevenir el calentamiento de las extremidades y, eventualmente, la administración de vasodilatadores y heparina. En caso de necrosis hepática secundaria al paracetamol, hay que administrar acetilcisteína en las primeras 24 a 36 horas, siendo la eficacia mayor cuanto más precoz sea la actuación. **PRESENTACIÓN:** Caja de 20 comprimidos.

Información complementaria bajo pedido  
DIDSAM070702

migrétil®